



1. Chest Pain

1.1 Description:

در این فایل توضیحات در رابطه با منطق و دانش پزشکی است که ایجنت بر اساس آن تصمیم میگیرد. به بیان ساده: میگه Risk Assessment Agent بر چه منطق یا مبنای پزشکی تصمیم میگیرد نه اینکه WORKFLOW ایجنت را رسم یا مرحله به مرحله توضیح دهم. در ادامه برای تست ایجنت، از درد قفسه سینه شروع میکنیم نه تمام بیماری ها، به این دلیل که اگر به طور یکجا اطلاعات تمام بیماری ها رو به ایجنت بدهیم، و اگر در مرحله ای اشتباه کند تشخیص یا دیباگ کردن سخت میشود و همچنین نمیتوانیم مطمئن شویم که WORKFLOW به درستی اجرا شده است یا نه. در ادامه اطلاعات درد قفسه سینه را به ایجنت خواهیم داد:

درد قفسه سینه به چند دلیل رخ میدهد:

✚ ممکن است بیمار دچار عارضه آنژین صدری باشد

✚ حمله قلبی

✚ رفلاکس معده

✚ اضطراب

✚ آمبولی ریه

✚ پریکاردیت یا PE

این عارضه ها شایع هستند که می تواند در اثر یک مشکل جزئی به وجود بیایند و یا عامل بروز آن به قدری جدی باشد که زندگی بیمار را تهدید کند. ایجنت تریاژ باید شدت و عوامل خطر را بررسی کند و سطح فوریت یا اورژانسی بودن را مشخص کند. در ادامه علائم مهم، نشانه های خطر و دیگر اطلاعات مهم را برای تصمیم گیری ایجنت معرفی خواهیم کرد:

1.2 symptoms:

علائم:

✚ احساس فشار

✚ حلت تهوع

تنگی نفس

ضربان قلب نامنظم

تب

سرفه مخاطی به رنگ زرد-سبز

ضعف

سوزش سردل زیاد بعد از خوردن غذا

اضطراب

ضربان قلب سریع

سرفه همراه لخته خون

1.3 risk factors:

عوامل افزایش دهنده ریسک:

سابقه بیماری قلبی

سابقه بیماری آنژین صدری

سابقه بیماری درد استنت

سابقه بیماری پریکاردیت یا PE

سابقه بیماری آمبولی ریه

سابقه بیماری رفلاکس معده

و اضطراب زیاد

1.4 Red flags:

نشانه های خطر:

از دست دادن هوشیاری

درد قفسه سینه همراه با تنگی نفس

درد بیشتر از 15 دقیقه طول کشد و با استراحت کاهش پیدا نکند و اسپری آنژینین یا نیتروگلیسیرین تاثیر نگذارد.

درد شدید و کشنده مداوم

حالت تهوع

1.5 Triage decision:

مرحله تصمیم گیری:

اگر بیمار درد قفسه سینه طولانی مدت همراه با تنگی نفس یا کاهش سطح هوشیاری و یا حالت تهوع داشته باشد:

risk level = High

+

Action:

و مرحله اکشن ارزیابی پزشکی است، که وضعیت را اورژانسی توصیه میکند.

1.6 System Rule:

تعریف قوانین یا منطق پزشکی برای ایجنٹ با زبان ماشین :

If chest_pain = True

AND (breathing_problem = True and (unconscious = True or Conditioners=True))

Risk level = High

1.7 Source/Reference(RGA):

منابع (Clinical Guideline):

ESI Handbook: 

فهم Level های تریاژ (Level 1 تا 5)، معیارهای High Risk، نحوه اولویت بندی بیمار.

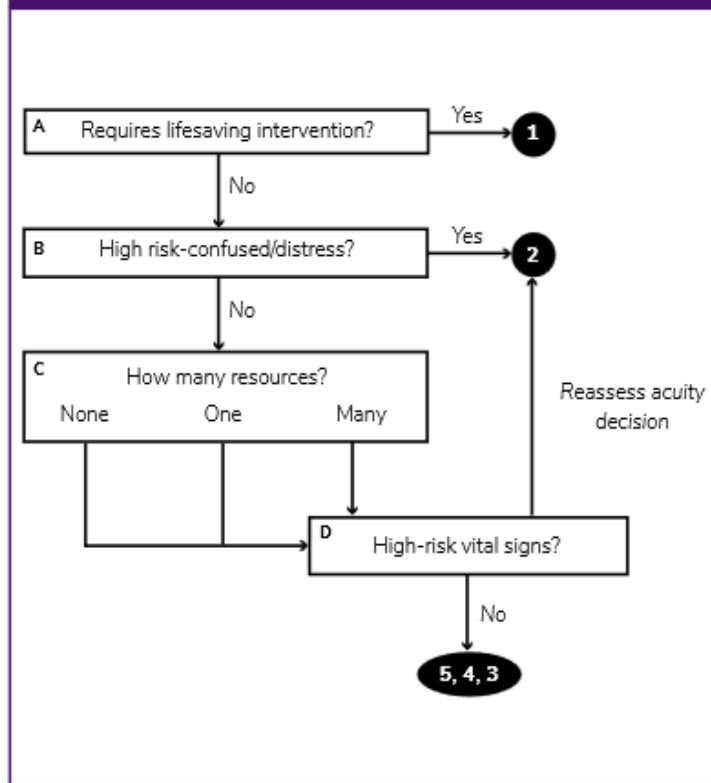
WHO Guidelines: 

محدودیت های AI پزشکی، Human Oversight، Safety در سیستم های سلامت.

AHRQ Resources: 

Clinical Decision Support، جلوگیری از خطای سیستم، اصول تصمیم گیری ایمن.

Figure 2-1. Emergency Severity Index Conceptual Algorithm



ESI برای استفاده پرستارانی ، با تجربه پرستاری اورژانس و تریاژ در نظر گرفته شده است. اولین تصمیمی که پرستار تریاژ می گیرد در مورد پایداری است. اگر بیماری معیارهای ناپایداری پرخطر سطح 1 یا 2 (**ESI**) را نداشته باشد، پرستار تریاژ سپس نیازهای منابع مورد انتظار را برای کمک به تعیین سطح تریاژ سطح 3، 4 یا 5 (**ESI**) ارزیابی می کند.

قضاوت های حاد در ابتدا بر اساس ارزیابی پایداری فیزیولوژیکی یا روانی و نیاز به مداخله فوری نجات بخش است. نقطه تصمیم گیری **A** تنها نقطه مورد نیاز برای بیماران سطح 1 **ESI** است که به عنوان نیازمند مداخله فوری نجات بخش تعریف می شوند. نقطه تصمیم گیری **B** برای تعیین اینکه آیا بیمار احتمالاً رو به وخامت می رود و/یا بر اساس علائم و عوامل خطر بیمار به مراقبت فوری بیشتری نیاز دارد، استفاده می شود. به این بیماران

سطح 2 **ESI** اختصاص داده می شود. هر دوی این تصمیمات ممکن است نیاز به مجموعه ای کامل از علائم حیاتی و ارزیابی متمرکز قبل از رسیدن به چنین تصمیمی داشته باشند. نقطه تصمیم گیری **C** تنها پس از حذف سطح 1 و 2 و تعیین وضعیت پایدار فیزیولوژیکی بیماران با خطر پایین برای وخامت استفاده می شود. این مرحله مستلزم پیش بینی منابع مورد نیاز در طول یک دوره معمول اورژانس برای بیماران با علائم مشابه است. منابع در الگوریتم کامل فهرست شده اند و در فصل 5 بیشتر به آنها پرداخته شده است. سطوح 3 **ESI** ، 4 و 5 بر اساس تعداد منابعی است که پرستار پیش بینی می کند برای رسیدن به یک تصمیم در مورد تعیین تکلیف استفاده خواهد شد. در این مرحله مراحل به صورت کلی توضیح داده شده است برای دانستن جزئیات قوانین باید به لینک پایین سر زد که تمام قوانین **ESI** داخل فایل به تعداد صفحه 36 آمده است.

[ESI Handbook Link](#)